

Yabancı Cisim Yutma

Yutulan yabancı cismin türü ve lokalizasyonuna göre risk katmanlaması; düğme pil ve çoklu mıknatısta acil endoskopi, keskin/uzun cisimlerde zamanlama, künt cisimlerde izlem vs çıkarma kararı. İki düzlemli grafi temelli, dozlu mitigasyon ve komplikasyon izlemi.

Düğme pil — ESPGHAN/NASPGHAN

Mıknatıs acil endoskopi

Lokalizasyon — iki düzlemli grafi

İzlem vs çıkarma

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Yabancı cisim yutma, çoğunlukla 6 ay–4 yaş arası çocukta görülen sık bir acildir; yutulan cisimlerin yaklaşık %80-90'ı komplikasyonsuz spontan geçer, %10-20'si endoskopik çıkarma, ~%1'i cerrahi gerektirir. İlk ve en kritik adım, "yüksek riskli" cismi (düğme pil, çoklu mıknatıs veya mıknatıs+metal, keskin/sivri cisim, uzun cisim, süperabsorban boncuk) hemen tanıyıp acil müdahaleyi gerektiren senaryoyu ayırmaktır. Karar; cismin türü, boyutu, sayısı, lokalizasyonu (özofagus/mide/ötesi) ve semptom varlığına dayanır.

Özofagus düğme pili = 2 saat içinde çıkar

Çoklu mıknatıs = acil

Keskin cisim özofagus/mide = acil

Künt-asemptomatik mide = izlem

Kusturma/körlemesine bujinaj YOK

Öykü

- Ne yutuldu, kaç adet, boyut: pil çapı (≥ 20 mm CR2032 tipi lityum hücre yüksek risk), mıknatıs sayısı ve ek metal cisim, cismin uzunluğu ve keskinliği.
- Yutma zamanı: özofagus düğme pilinde doku hasarı 2 saatte başlar; bal mitigasyonu için "son 12 saat" penceresi belirleyicidir.
- Semptomlar: disfaji, odinofaji, salya yutamama/aşırı salivasyon, retrosternal ağrı, kusma, hematemez, karın ağrısı, ateş — mukozal hasar/perforasyon ipuçları.
- Solunum bulguları: öksürük, stridor, hışıltı, boğulma hissi (hava yolu basısı veya aspirasyon).
- Tanıksız yutma olasılığı, tekrarlayan yabancı cisim öyküsü, altta yatan özofagus patolojisi (EoE, striktür, ÖA onarımı, akalazya) ve nörogelişimsel durum.
- Süperabsorban su boncuğu/oyuncak: başlangıçta küçük olup GİS'te genişleyerek obstrüksiyon yapabilir, radyolüsendir.

Muayene

- Genel durum, hava yolu ve solunum güvenliği; stridor/retraksiyon acil hava yolu değerlendirmesi gerektirir.
- Salya birikimi, salgıyı yutamama ve öğürme — tam/proksimal özofagus obstrüksiyonu işareti.
- Boyun/göğüs: subkutan amfizem, boyun hassasiyeti, krepitasyon (perforasyon).
- Karın muayenesi: distansiyon, hassasiyet, defans/rebound, barsak sesleri — mıknatıs ilişkili obstrüksiyon/perforasyon/peritonit taraması.
- Orofarinks: cismin ağız/farinkste kalıp kalmadığı, mukozal yaralanma, kanama.

- Ateş ve hemodinami: geç perforasyon/mediastinit veya aortoözofageal fistül açısından uyanık ol.

Anahtar ilke: Özofagusta yerleşmiş bir düğme pil, semptom olsun olmasın ve son öğün zamanından bağımsız olarak 2 saat içinde çıkarılmalıdır; gecikme sıvılaşma nekrozu, perforasyon, trakeoözofageal veya aortoözofageal fistülle sonuçlanabilir. Kusturma ve körlemesine bujinaj/Foley kontrendikedir.

Yönetim, yutulan cismin sınıfına göre değişir. Aşağıdaki altı kategori hem hasar mekanizmasını hem de aciliyet düzeyini belirler: düğme pil (elektrokimyasal hidroliz), mıknatıslar (bası nekrozu/fistül), keskin cisimler (perforasyon), künt cisimler (obstrüksiyon), uzun cisimler ve süperabsorbanlar, gıda bolusu (altta yatan özofagus hastalığı).

Düğme pil (button/coin cell)

- Mukozal temas noktasında lokal akım → hidroksil üretimi, alkali sıvılaşma nekrozu; hasar 2 saatte başlar.
- Özofagusta = mutlak acil (çıkar <2 saat). ≥20 mm lityum hücre <5 yaş çocukta özofagusa takılmaya çok yatkın.

Mıknatıslar (özellikle neodmiyum)

- Tek mıknatıs + ek mıknatıs/metal yok → künt cisim gibi yönetilir.
- Çoklu mıknatıs veya mıknatıs+metal: barsak duvarlarını sıkıştırıp bası nekrozu, fistül, perforasyon, obstrüksiyon, volvulus yapar → acil.

Keskin / sivri cisimler

- İğne, toplu iğne, kürdan, kılçık, cam, açılmış ataş; perforasyon riski %15-35'e ulaşır.
- Özofagus, mide veya ulaşılabilir duodenumda → acil/ivedi endoskopik çıkarma.

Künt cisimler (bozuk para, oyuncak)

- En sık yutulan; bozuk para tipiktir. Asemptomatik ve mideye geçmişse çoğu spontan atılır.
- Özofagus bozuk parası: asemptomatikte kısa gözlem, aksi halde 24 saat içinde çıkarma.

Uzun cisimler ve süperabsorbanlar

- >5 cm (süt çocuğu) / >6 cm uzunluk pilor–duodenum kıvrımını geçemez → mideden çıkar.
- Su boncuğu/süperabsorban polimer: GİS'te şişip obstrüksiyon yapar, radyolüsendir; küçük çocukta çıkarmaya eğilimli ol.

Gıda bolusu impaksiyonu

- Genellikle altta yatan özofagus hastalığını (EoE, striktür, halka) işaret eder.
- Endoskopik çıkarmada mutlaka EoE için çok düzeyli biyopsi alınır; papain/et yumuşatıcı kullanılmaz.

Düğme pil ve çoklu mıknatıs, "sessiz" olsalar bile en yüksek öncelikli iki senaryodur: pil elektrokimyasal yanık, mıknatıslar duvarlar arası bası nekrozu yapar. İkisinde de bekleme değil, lokalizasyon ve acil endoskopi/cerrahi planı esastır.

03 Karar akışı

Akış, cismi iki düzlemli grafiyle lokalize edip önce yüksek riskli senaryoları (özofagus düğme pili, çoklu mıknatıs, özofagusta keskin cisim veya tam obstrüksiyon) dışlamak, ardından künt/aseptomatik cisimlerde izlem-çıkarma kararını vermek üzerine kurulur.

BAŞLANGIÇ

Yabancı cisim yutma ile başvuru

Ne, kaç adet, boyut ve zaman; hava yolu ve semptom taraması. Kusturma yok, oral alım durdurulur.

ADIM 1

İki düzlemli grafi ile lokalizasyon

Boyun-göğüs-karın AP + lateral grafi. Pilde AP'de "çift halka/halo", lateralde "basamak (step-off)" işareti bozuk paradan ayırır; radyolüsen cisimde metal dedektör/BT düşün.

KARAR 1

Düğme pil VEYA çoklu mıknatıs/mıknatıs+metal mı?

Özellikle özofagus yerleşimli pil ya da birden fazla mıknatıs saptandı mı?

EVET → En yüksek öncelik

HAYIR → Diğer cisimler

ALARM

Acil endoskopik çıkarma

Özofagus pili <2 saatte çıkar; ≥12 ay ve <12 saat ise yolda/hazırlıkta bal mitigasyonu. Çoklu mıknatıs özofagus/mide/ulaşılabilir duodenumda → acil endoskopi; ulaşamıyorsa cerrahi konsültasyon + seri grafi.

ADIM 2

Keskinlik ve obstrüksiyon değerlendir

Cismin keskin/sivri olup olmadığı ve tam özofagus obstrüksiyonu (salgı yutamama) sorgulanır.

KARAR 2

Özofagusta keskin cisim veya tam obstrüksiyon mu?

Keskin/sivri cisim (herhangi düzey özofagus/mide) ya da salgıyı yutamama var mı?

EVET → Acil endoskopi

HAYIR → Künt cisim yolu

ALARM

İvedi terapötik endoskopi

ADIM 3

Künt cismin düzeyini belirle

Keskin cisim özofagus/mide/ulaşılabılır duodenumda acil çıkarılır (perforasyon riski %15-35). Tam obstrüksiyonda hava yolu korunarak acil endoskopi; gıda bolusunda EoE biyopsisi al.

Cisim özofagusta mı, mide veya ötesinde mi; semptom var mı?

KARAR 3

Künt cisim özofagusta mı?

Bozuk para/oyuncak gibi künt cisim özofagusta takılı mı?

EVET → İvedi (24 saat)

HAYIR → Mide/ötesi

ADIM 4A

İzlem penceresi ± endoskopi

Asemptomatik distal bozuk parada 12-24 saat spontan geçiş için gözlem seçilebilir; semptomatikse veya geçmezse 24 saat içinde endoskopik çıkarma.

ADIM 4B

Yüksek riskli özellik taraması

Mide/bağırsaktaki cisimde uzunluk, çap, pil boyutu ve semptom değerlendirilir.

KARAR 4

Mide/bağırsakta yüksek riskli özellik var mı?

Uzunluk >5-6 cm, çap >2.5 cm, ≥20 mm pil (<5 yaş) veya semptom/geçiş yokluğu var mı?

EVET → Girişim

HAYIR → İzlem

ADIM 5

Endoskopik/cerrahi çıkarma

Uzun/geniş cisim mideden endoskopik çıkarılır. Büyük gastrik pil 48 saatte geçmezse veya semptom varsa çıkar; pilor ötesindeki keskin/mıknatısta seri grafi + cerrahi eşiği düşük.

SONLANIM

Ayaktan izlem + dışkı takibi

Asemptomatik künt mide cisminde evde gözlem; dışkıda cisim aranır, semptomda geri başvuru. Geçmezse 2-4 haftada kontrol grafi.

Zamanlama üçlemesi: ACİL (<2 saat) — özofagus düğme pili, özofagusta keskin cisim, tam obstrüksiyon, ulaşılabılır çoklu mıknatıs. İVEDİ (<24 saat) — özofagus künt cisim/gıda bolusu, mide keskin cismi, ≥6 cm uzun cisim, semptomatik/büyük gastrik pil. İZLEM — asemptomatik künt gastrik cisim.

Görüntülemenin amacı cismi tanımlamak, düğme pili bozuk paradan ayırmak ve lokalizasyonla aciliyeti belirlemektir. İki düzlemli (AP + lateral) grafi standarttır; lateral grafi pil basamak işaretini ve trakeal-özofageal ayrımı gösterir. Radyolüsen cisimlerde ek yöntemler gerekir.

Yabancı cisim yutmada basamaklı tanısal yaklaşım		
BASAMAK / TEST	NE ZAMAN	AMAÇ VE
İki düzlemli radyografi (boyun-göğüs-karın)	AP + lateral, tüm olgular	İlk basamak Metalik/radyolüsen cismin türü ve düzeyi ve belirlenir; lümen hava ve sıvı amfizem t
Pil-bozuk para ayrımı (halo/step-off)	Yuvarlak metalik cisimde	AP'de çift lateralde k (step-off) i pili gösterir hayat kurt tereddütle
Çoklu mıknatıs sayımı	Mıknatıs şüphesi	Üst üste b mıknatısla gibi görün açı/düzlen ile ayrı ayı metal aran
El tipi metal dedektörü	Bilinen metalik künt cisim (bozuk para)	Radyasyo lokalizasy asemptom bozuk par grafi yerin kullanılabil Pil/mıknat ekartasyo gerekir.

BASAMAK / TEST	NE ZAMAN	AMAÇ VE
Radyolüsen cisim değerlendirme	Plastik, cam, kılçık, ahşap, su boncuğu	Grafi norm kuvvetli ve semptomat doğrudan gerekirse aspirasyon riski ve en görüşünü bozacağır
Üst GiS endoskopisi (tanısal + terapötik)	Yüksek riskli / semptomatik / özofagus	Hem çıkar mukoza h evrelemes bolusunda distal ≥ 6 b EoE araşt
Seri radyografi ile geçiş takibi	Pilor ötesi keskin/mıknatır; büyük gastrik pil	Keskin cis büyük gas saatte kor yoksa vey varsa giriş
BT anjiyografi / kesitsel görüntüleme	Perforasyon/fistül şüphesi, pil sonrası ağır hasar	Mediastini aortoözofa şüphesinde özofagus damar kor değerlendir cerrahi pla

Yuvarlak metalik cisimde düğme pil ile bozuk parayı ayırmak için lateral grafi zorunludur; ayırım net değilse cisim düğme pil kabul edilip acil yönetilmelidir.

Aşağıdaki bulgular acil endoskopi/cerrahi ve yoğun izlem gerektirir; "spontan geçer" varsayımını geçersiz kılar.

● Özofagusta düğme pili — semptom ve zamandan bağımsız 2 saat içinde çıkar.

● Çoklu mıknatıs veya mıknatıs+metal cisim yutma.

● Özofagusta keskin/sivri cisim veya salgıyı yutamama (tam obstrüksiyon).

● Solunum sıkıntısı, stridor, hışıltı — hava yolu basısı/aspirasyon.

● Hematemez, melena veya masif kanama işareti (özellikle pil sonrası geç dönem).

● Boyun/göğüs krepitasyonu, subkutan amfizem, göğüs/sırt ağrısı (perforasyon/mediastinit).

● Karında distansiyon, defans, rebound, safralı kusma (mıknatıs ilişkili obstrüksiyon/peritonit).

● Ateş, taşikardi, kötüleşen genel durum — geç komplikasyon.

● Süperabsorban boncuk yutan küçük çocukta ilerleyici obstrüksiyon bulguları.

● Pil çıkarıldıktan sonra bile 2-4 hafta içinde masif hematemez (aortoözofageal fistül).

Kesin yasaklar: kusturma/ipeka, körlemesine bujinaj, deneyimsiz elde Foley kateter denemesi (pil/keskin/mıknatısta asla), papain-et yumuşatıcı (özofagus perforasyonu). Bunlar hasarı artırır.

06 Tedavi — dozlu

Definitif tedavi endoskopik/cerrahi çıkarmadır; medikal ajanlar sınırlı ve yardımcıdır. Düğme pil mitigasyonu (bal/sukralfat) endoskopiye köprüdür, onu geciktirmez. Gıda bolusunda farmakolojik gevşeticiler zayıf kanıtlıdır. Dozlar hastaya göre bireyselleştirilir.

Pil: bal → sukralfat → acil endoskopi

Çoklu mıknatıs: endoskopi/cerrahi

Keskin/uzun: endoskopik çıkarma

Künt-aseptomatik: izlem

Yabancı cisim yönetiminde ajanlar/girişimler — doz ve zamanlama

AJAN / GİRİŞİM	DOZ (MG/KG + MAKSİMUM) / ZAMANLAMA
Bal (düğme pil mitigasyonu)	10 mL PO, her 10 dakikada bir, en çok 6 doz
Sukralfat süspansiyon (hastane içi mitigasyon)	10 mL (1 g/10 mL) PO, her 10 dakikada bir, en çok 6 doz
Acil endoskopik çıkarma — özofagus pili	<2 saat (aç kalma beklenmeden)
Endoskopik/cerrahi — çoklu mıknatıs	Ulaşılabilir → acil endoskopi; ötesi → cerrahi kon

AJAN / GİRİŞİM	DOZ (MG/KG + MAKSİMUM) / ZAMANLAMA
Endoskopik çıkarma — keskin cisim	Özofagus/mide/ulaşılabilir duodenum: acil
Endoskopik çıkarma — uzun/geniş cisim	Uzunluk >5-6 cm veya çap >2.5 cm: mideden çıkarma
Gastrik düğme pil yönetimi	Asemptomatik: izlem; ≥20 mm ve 48 saatte geçme
Gıda bolusu — endoskopik çıkarma + biyopsi	Komplet obstrüksiyon: acil; değilse <24 saat
Glukagon (özofagus gıda bolusu — yardımcı)	0.02-0.03 mg/kg IV (tipik maks 0.5-1 mg)
Asemptomatik künt gastrik cisim — izlem	Ayaktan; 2-4 haftada kontrol grafi

Bal ve sukralfat yalnızca köprüleme amaçlıdır; hiçbir ösofagus pilinde 2 saatlik acil endoskopi hedefini ertelemeyiz. Perforasyon, sepsis şüphesi veya <12 ay/>12 saat durumunda mitigasyon verilmeden doğrudan endoskopiye geçilir.

07 İzlem ve yönetim ilkeleri

Amaç, çıkarma sonrası erken ve GEÇ komplikasyonları yakalamak, izleme alınan cisimlerde güvenli geçişi doğrulamak ve aileyi net dönüş ölçütleriyle taburcu etmektir. Özellikle ösofagus düğme pili, çıkarıldıktan sonra bile haftalarca izlenmelidir.

Yüksek riskli cisim sonrası izlem

- Ösofagus pili sonrası ağır hasarda NPO, yatış ve seri değerlendirme; gecikmiş perforasyon/fistül 2-4 hafta içinde bile ortaya çıkabilir.
- Aortoösofageal fistül alarmı: taburculuk sonrası herhangi bir hematemez acil geri başvuru gerektirir; ailelere açıkça anlatılır.
- Mıknatıs olgusunda çıkarma sonrası veya cerrahi sonrası obstrüksiyon/perforasyon açısından karın izlemi ve gerektiğinde tekrar görüntüleme.
- Keskin cisim çıkarıldıysa mukozal hasar ve kanama; pilor ötesindeyse ilerleyene dek günlük grafi.

İzleme alınan cisim ve taburculuk kuralları

- Asemptomatik künt gastrik cisimde evde dışkı takibi; 2-4 haftada geçmezse kontrol grafi ve çıkarma.
- Aileye kesin dönüş ölçütleri: kusma, karın ağrısı/şişkinlik, ateş, dışkıda kan, disfaji, solunum sıkıntısı.
- Gıda bolusu sonrası EoE biyopsisi pozitifse PPI/topikal steroid/eliminasyon diyeti ile hastalığı yönet; nüksü önlemek için idame ve endoskopik izlem.
- Önleme danışmanlığı: düğme pilli cihazların güvenli saklanması, mıknatıslı oyuncak/manyetik yapı taşlarından kaçınma, su boncuğu farkındalığı.

Devam ve geri çekilme kuralı: Ösofagus pili düşük eşikle acil çıkarılır ve sonrasında komplikasyon riski geçene dek izlenir; künt asemptomatik gastrik cisimlerde ise girişim değil, net dönüş ölçütleriyle güvenli izlem esastır. Kararsız her yuvarlak metalik cisim pil kabul edilir.

Kaynaklar

1. Kramer RE, Lerner DG, Lin T, ve ark. Management of ingested foreign bodies in children: a clinical report of the NASPGHAN Endoscopy Committee. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2015;60(4):562-574.
2. Mubarak A, Benninga MA, Broekaert I, ve ark. Diagnosis, management, and prevention of button battery ingestion in childhood: A ESPGHAN position paper. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2021;73(1):129-136.
3. Thomson M, Tringali A, Dumonceau JM, ve ark. Paediatric gastrointestinal endoscopy: ESGE and ESPGHAN Guideline. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017;64(1):133-153.
4. Anfang RR, Jatana KR, Linn RL, ve ark. pH-neutralizing esophageal irrigation as a novel mitigation strategy for button battery injury. Laryngoscope. 2019;129(1):49-57.

Uyarı: Bu belge çocuk gastroenteroloji uzmanları için klinik karar desteği amaçlıdır; hastaya özgü değerlendirmenin, güncel kılavuzların ve yerel ilaç ruhsat/dozaj bilgilerinin yerine geçmez. Dozlar ve zamanlama; hastanın yaşı, kilosu, cismin türü/boyutu ve komorbiditelerine göre bireyselleştirilmelidir.